



# 埃博拉病

2025年4月24日 | 阅读时间 12 分钟 (3237 字)

[English](#)

[العربية](#)

[Français](#)

[Русский](#)

[Español](#)

## 重要事实

- 埃博拉病是一种严重且往往致命的人类疾病。
- 已知有三种不同的病毒会导致大规模埃博拉病疫情：埃博拉病毒、苏丹病毒和本迪布焦病毒。
- 埃博拉病的平均病死率约为50%。在以往的疫情中，病死率从25%到90%不等。
- 及早通过补液和对症治疗进行重症监护支持可提高生存率。
- 目前已批准的疫苗和治疗方法仅适用于其中一种病毒（即埃博拉病毒），针对其他病毒的疫苗和治疗方法正在开发中。
- 疫情控制依赖一套干预措施，包括：对患者的重症监护支持、感染预防和控制、疾病监测和接触者追踪、实验室服务、安全和体面的埋葬、适用的疫苗接种以及社会动员。

## 概述

埃博拉病是一种罕见但严重的人类疾病(1)。它往往是致命的。

埃博拉病系由丝状病毒科正埃博拉病毒属的病毒所引起(2)。迄今为止，已确定了六种正埃博拉病毒，其中三种已知可引起大规模疫情：

- 引起埃博拉病毒病的埃博拉病毒
- 引起苏丹病毒病的苏丹病毒
- 引起本迪布焦病毒病的本迪布焦病毒。

埃博拉病于1976年首次出现在两起同时暴发的疫情中：一起是苏丹病毒病疫情，发生在现今南苏丹境内的恩扎拉；另一起是埃博拉病毒病疫情，出现在现今刚果民主共和国境内的亚布库。后一起疫情因发生在埃博拉河附近的一个村庄而得名。

虽然已有针对埃博拉病毒病的获许可疫苗和治疗方法，但没有针对其他埃博拉病（如苏丹病毒病或本迪布焦病毒病）的获准疫苗或治疗方法。候选产品正在开发中。

及早通过补液和对症治疗进行重症监护支持可提高生存率。及早就医可以挽救生命。

## 传播

据认为，狐蝠科的果蝠是正埃博拉病毒的天然宿主。该病毒可在人们密切接触受感染动物，如患病或死亡的或是热带雨林中的果蝠、黑猩猩、大猩猩、猴子、森林羚羊或豪猪等的血液、分泌物、器官或其他体液时进入人体。

人们可以通过直接接触（即经由破损的皮肤或粘膜）从他人那里感染病毒，这种接触包括：

- 埃博拉病患者或死者的血液或体液；以及
- 被该病的患者或死者的体液（如血液、粪便、呕吐物）污染的物体或表面。

该病毒的感染者只有在出现症状后才会传播疾病，只要其血液中含有此种病毒，他们就会一直具有传染性。

卫生和照护工作者经常在治疗埃博拉病患者期间受到感染。如果不严格执行感染控制和预防措施，就会通过与患者的密切接触而发生感染。

在葬礼上与死者尸体直接接触也会助长埃博拉病的传播。

## 症状

疾病潜伏期或从被感染到出现症状的时间为2至21天。

埃博拉病的症状可能突然出现，包括发烧、疲劳、不适、肌肉疼痛、头痛和喉咙痛。随后出现呕吐、腹泻、腹痛、皮疹以及肾和肝功能受损的症状。卫生和照护工作者必须注意这些症状。

尽管认为出血是一种常见症状，但这种情况并不经常出现，而且可能在疾病后期发生。有些患者可能会出现内出血和外出血，包括呕吐物和粪便中有血，以及鼻子，牙龈和阴道出血。针头刺破皮肤的部位也可能发生出血。

对中枢神经系统的影响可导致意识混乱、易怒和攻击性。

## 诊断

临床上可能很难将埃博拉病与其他传染病，如疟疾、伤寒、志贺氏菌病、脑膜炎及其他病毒性出血热区分开来，因为疾病早期的症状相似。

可采用以下诊断方法来确认是否感染正埃博拉病毒：

- 逆转录聚合酶链反应试验
- 抗体捕获酶联免疫吸附试验

- 抗原捕获检测法
- 通过细胞培养进行病毒分离。

从患者身上采集的样本具有极高的生物危害风险；对未灭活样本的实验室检测应在最高级别的生物防护条件下进行。在国内和国际范围内运输时，所有未灭活生物标本均应使用三重包装。参见[埃博拉病和马尔堡病的诊断检测](#)。

## 治疗

多年来，世卫组织和合作伙伴制定了[指导](#)和培训，概述了如何为患者提供尽可能最好的护理并提高其生存机会，无论是否使用特定的治疗方法。这被称为优化的支持性护理，涵盖应实施的相关检测，管理疼痛、营养和合并感染（如疟疾）的方法，以及让患者走上最佳康复道路的其他方法。

对于埃博拉病毒病，[世卫组织强烈建议](#)使用mAb114（ansuvimab™）或REGN-EB3

（Inmazeb™）进行治疗，这两者都是单克隆抗体。对于其他埃博拉病，如苏丹病毒病或本迪布焦病毒病，目前尚无获批准的治疗方法，[但候选产品正在开发中](#)，并且已有用于临床试验的[核心规程](#)。

## 疫苗

针对埃博拉病毒病：

- 有两种疫苗获得了批准：**Ervebo**（默沙东）以及**Zabdeno**和**Mvabea**（杨森制药）。建议将**Ervebo**疫苗作为疫情应对措施的一部分，参见[2024年7月免疫战略咨询专家组的建议](#)。
- 如果确认暴发埃博拉病毒病疫情，可通过[国际疫苗供应协调小组](#)获得**Ervebo**疫苗。
- 对于卫生保健和一线工作人员的预防性疫苗接种，可以通过[全球疫苗免疫联盟预防性埃博拉疫苗接种项目](#)申请**Ervebo**疫苗。

针对苏丹病毒病等其他埃博拉病：

- [几种候选疫苗](#)正处于不同的开发阶段。
- 作为疫情应对措施的一部分，可以使用[核心规程来评价候选疫苗的安全性、耐受性、免疫原性和效力](#)。

## 预防和控制

社区参与是成功控制所有疫情的关键。疫情控制依赖于一系列干预措施，例如临床护理、监测和接触者追踪、实验室服务、卫生机构中的感染预防和控制、安全和体面的埋葬、疫苗接种（仅针对埃博拉病毒病）以及社会动员。

提高人们对风险因素及个人能够采取的防护措施的认识可以有效减少人际传播。旨在降低风险的宣传工作应该侧重于以下几个因素：

- 减少因接触受感染的果蝠或猴子/猿以及食用其生肉而导致的从野生动物向人传播的风险。
- 减少由于直接或者密切接触感染者（尤其是其体液）而出现的人际传播风险。应避免与埃博拉患者的近距离身体接触。患者应在指定的治疗中心隔离，以便接受早期护理，避免在家传播。
- 社区应充分了解疾病本身情况和如何控制疫情。最好的做法是让社区参与应对工作，并进行公开讨论。
- 疫情控制措施包括[安全和体面地埋葬死者](#)，找到可能与埃博拉病感染者接触过的人并对其健康状况进行21天监测，将健康者与患者分开以防止进一步传播，并为确诊患者提供护理。保持良好的个人卫生和清洁的环境也很重要。

## 控制卫生保健机构中的感染

无论推定的诊断结果如何，卫生保健工作者在医治和护理患者时应始终采取[标准预防措施](#)。这些预防措施包括基本手卫生、呼吸卫生、使用个人防护装备（防止飞溅或以其他方式接触受到感染的物品）、采用安全注射方法以及安全和体面的埋葬方法。

照护疑似或确诊埃博拉病患者的卫生保健工作者应采取额外的感染控制措施，以防止接触患者的血液和体液以及衣物和被褥等受到污染的表面或材料。[埃博拉病和马尔堡病感染预防和控制指南](#)。

实验室工作人员也面临风险。用于调查正埃博拉病毒感染的人类和动物样本应由训练有素的工作人员在配有适当设备的实验室中进行处理。

## 幸存者的护理

所有幸存者、其伴侣和家人都应得到尊重、尊严和同情。世卫组织不建议对血液检测结果呈正埃博拉病毒阴性的康复患者进行隔离。幸存者可能会遭受临床和心理后遗症。世卫组织鼓励受影响国家考虑[制定一个护理规划](#)，以减轻后遗症，支持重返社区，提供咨询和进行生物检测。

已知正埃博拉病毒会在一些康复者的免疫豁免部位持续存在。这些部位包括睾丸、眼睛内部和大脑。如果没有再次感染，埃博拉病康复患者出现疾病症状反复是一种罕见的情况，但有相关记录。造成这种现象的原因尚不完全清楚。

有记录表明，埃博拉病毒可通过受感染的精液传播，时间可长达临床恢复后15个月。为了降低这种传播的风险，应实施精液检测规划，以便：

- 向男性幸存者及其性伴侣提供咨询，告知他们潜在的风险，并支持他们坚持[更安全的性行为](#)（包括提供安全套以及保持良好的手卫生和个人卫生）；
- 提供每月一次的精液检测，直到连续两次检测结果呈阴性；以及
- 在连续两次检测结果为阴性后，幸存者可以安全地恢复正常的性行为，此时病毒传播的风险已降至最低。

在没有精液检测规划的情况下，男性幸存者应在12个月当中采用更安全的性行为做法。

正埃博拉病毒可能在怀孕期间受到感染的妇女的胎盘、羊水和胎儿中持续存在，也可能在感染该病毒的哺乳期妇女的母乳中持续存在。幸存者护理规划应包括对康复后的孕妇和哺乳期妇女的护理。

# 世卫组织的应对

世卫组织与各国合作，通过持续开展监测工作和支持高风险国家制定准备计划，预防埃博拉疫情。以下文件为控制埃博拉和马尔堡病毒疫情提供了总体指导：[埃博拉和马尔堡病毒病疫情：准备、警报、控制和评估](#)。

在发现疫情时，世卫组织通过支持疫情应对、发现疾病、社区参与、接触者追踪、疫苗接种、疫苗和疗法试验、病例管理、实验室服务、感染控制、物流以及对安全和体面的埋葬做法进行培训和提供援助的方式来应对疫情。

## 参考文献

1. 《国际疾病分类》第十一次修订本，2024年：[《国际疾病分类》](#)。
2. 国际病毒分类委员会：  
<https://ictv.global/report/chapter/filoviridae/filoviridae/orthoebolavirus>